جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هبة سعيد سعيد بدران
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مدينه السلام **العنوان :** السلام القاهرة
رقم البطاقة : 28010270102981 **رقم التليفون :** 01113594637 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-10-1980 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هبة سعيد سعيد بدران
National ID: 28010270102981

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

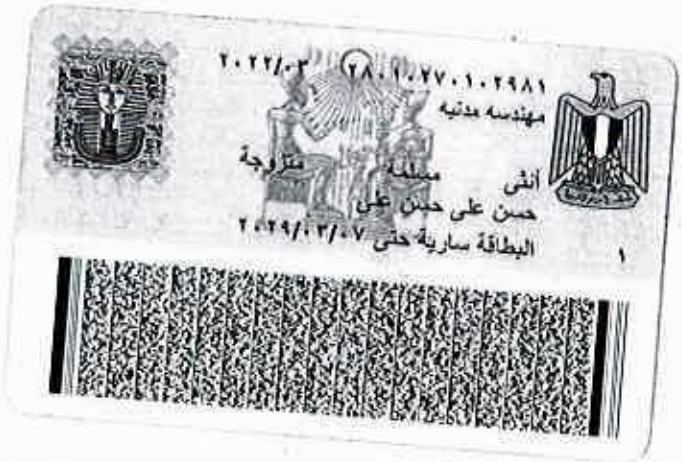
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



ملحقه



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 17/7/2025 G

Name	هبة سعيد سعيد يزدان	MRN	
		ID	64/2025.
Age	44 yrs.	Phone	01113594637
Menopausal status	Irregular.	Marital status	CA.1.CV.1.C9A
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	Post-op.
CO morbidity	M → -ve S → C.S		

Irritability →

Clinical Data

Bx: IDC, GTI.

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
7/8	6/8	2 by Amplified	Amplified

R L

Sonomammography:

→ Post Q1 SM + SLNB, Post NACT

→ NACT. TCHP x 6. (7 phases)

Mets Workup:

→ No residual tumour.

→ -ve margin.

→ SLNB 0/4.

ypT0N0

TNM

Recommendations:

→ Complete Pathological report To Tumor Board. 17/7/25

For possible of Adj RT

Oncology 13/7/2025

MDT OUTCOME & PLAN

① RT

② Continue phenyto up to 1 yr

③ Tamoxifen 2 yrs then Re MDT for AI

+ Zolodex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: هبه سعيد سعيد بدران **MR. :** 2127	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

PREM RT BREAST CANCER CT2 NO MO ER7/8 PR6/8 2+ REC TCHP ON 30/6/20225 RT MRM CR YPN0/2 ST ZOLADEX TAM FOR C16 PHESGO EF 65% 12/2025 DUE 26/2 C17 PHESGO

for c17 phesgo tamoxifen zoladex given on 5/2/2026

for tamoxifen for 3 m zoladex due date 30/4 for us breast

for tamoxifin 20 mg investigations requested next follow visit after follow up 1m

PAUS + BBSM + TVUS 6/2026 >> all within normal for tam 20mg + zoladex 3 months

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **dina makram**

يعتمد ,

tient Name	: الأستاذه / هبه سعيد سعيد بدران	Request No.	: 13002494
tient No.	: 28010270102981	Request Date	: 09/01/2025
n No.	: SR-38/25	Verification Date	: 16/01/2025
x	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
e	: 44 Y	Department	: Out Patient
ferreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

nical Data: Right breast cancer.
ture of Specimen: Slide Revision

oss Examination:
one paraffin block labeled by (8345-24) and four immuno-stained slides were received.

croscopic Examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III.
PT:
ER: Moderate nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 7/8).
PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
ISH: Amplified.
verage Her2 copy No. > (4.35), Her2/CEP17 ratio > (3.65))

agnosis:
ght breast mass, Slide Revision:
vasive duct carcinoma, Grade III.
T:
ER: Positive (score 7/8).
PR: Positive (score 6/8).
Her2: Equivocal (score 2+).
ISH: Amplified.

Signature
Dr. Salam Tarek
Dr. Heba Hasan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	: الأستاذه / هبه سعيد سعيد بدران	Request No.	: 13003618
Patient No.	: 28010270102981	Request Date	: 30/06/2025
Path No.	: 2169/25	Verification Date	: 07/07/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقدة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Right simple mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy.

Gross Examination:
* Right simple mastectomy specimen measured 20x18x4 cm, with covering skin measured 20x15 cm.
* N & A: Looked unremarkable grossly.
* Serialling showed tumor bed site 6x5x3 cm & a rubbery grey white area 3x2x1 cm, located 1 cm apart and the least inked deep margin was 0.2 cm away.
* Sentinel lymph nodes: Fibrofatty tissue measured 4x3 cm, entangling 4 lymph nodes, up to 1x1x0.5 cm.

* 13 Blocks:
1:6- T.B.S., 7- Area inbetween., 8:10- G/W area., 11- N&A., 12- Inked deep margin., 13- SLNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

* Frozen Results:
- Free sentinel lymph nodes (0/4).

Microscopic Examination:
* Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- Cellularity (0%).
* Angioinvasion: Not detected.
* Ductal carcinoma in situ: Not detected.
* Nipple & areola: Free.
* Deep margin: Free.
* Sentinel lymph nodes: Free 4 lymph nodes, LNs (0/4).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / هبه سعيد سعيد بدران	Request No.	: 13003618
Patient No.	: 28010270102981	Request Date	: 30/06/2025
Path No.	: 2169/25	Verification Date	: 07/07/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

* Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:
Right breast cancer (Post-NACT), Right simple mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy:
- No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- No DCIS.
- Deep Margin: Free.
- Nipple & areola: Free.
- Sentinel lymph nodes: Free 4 lymph nodes, LNs (0/4).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0(sln).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.
Dr. Heba Hassan Adly.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: heba saayd saayd bdren
GENDER: Female
DATE : 05-Jan-2025 05:17 PM

PATIENT ID: 2019074316
AGE: 44 y
ORDER: 3195690,3196316

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:
- Right breast pathologically proved invasive duct carcinoma.

TECHNIQUE:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion 100 ml of omnipaque
- Targeted ultrasound.

FINDINGS:
RIGHT BREAST:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate asymmetrical back ground parenchymal enhancement.
- LOQ heterogeneously enhancing irregular mass is noted, measuring about 2.6x2.3x2.2cm cm in maximum dimensions, being 7 cm from the nipple.
- Associated heterogeneous non-mass enhancement is noted mainly medial and posterior to the fore-mentioned mass, the mass ans non mass enhancement collectively occupying an area measuring about 6x5.3x5.3cm in maximum dimensions. 2nd look ultrasound revealed corresponding altered parenchymal echogenicity, located at 8:00, 2.5 cm posterior to the fore-mentioned mass.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.

LEFT BREAST:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate asymmetrical back ground parenchymal enhancement.
- UOQ paraareolar small circumscribed enhancing nodule, with no ultrasound correlate.
- Normal skin thickness and contour.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

PATIENT NAME: heba saayd saayd bdren
GENDER: Female
DATE : 23-Dec-2024 04:57 PM

PATIENT ID: 2019074316
AGE: 44 y
ORDER: 3178566,3178864

RT SIDED 3D DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Routine screening.
- Positive family history (mother 40 ys and sister 32 ys)

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- Dense fibroglandular parenchyma. (ACR c)
- No spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- Site of clinical concern at RT LOQ zone c at about 8 to 9 o'clock is the seat of newly developed high density lesion with overlying faint calcifications seen by US as irregular heterogenous hypoechoic solid mass lesion measuring about 31x12.6 x13 mm
- Complementary Ultrasound showed prominent glandular tissue with increased echogenicity and mottling appearance denoting adenosis with few scattered variable sized cysts
- No other gross solid mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Bilateral likely Nonspecific axillary lymph nodes.

OPINION:

- **Bilateral fibrocystic mammary changes with RT LOQ suspicious lesion for further pathological assessment . (BIRADS 4)**

RECOMMENDATION:
Referral to clinic

Reported By,

Prof.Dr. Omnia Mokhtar, MD 23-Dec-2024 06:51 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Heba Saeed Saeed Badran	Date : 08/01/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 64/2025	Pat. ID: 96735

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- **No available clinical data or previous studies for comparison.**

I Chest:

- Few bilateral pulmonary nodules the largest is middle lobar reaching 5.5 mm.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous parenchymal attenaution. It shows perifalciform hypodense area mostly pseudolesion for follow up otherwise, no sizable focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non-contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- Bilateral adnexal heterogenous cystic lesions the largest is on the left side seen measuring 4 X 3 cm
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

No available clinical data or previous studies for comparison.

- **Bilateral pulmonary nodules for follow up.**
- **Bilateral adnexal heterogenous cystic lesions for sonographic assessment.**
- **For correlation with the unavailable data.**

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]